TOME 27 • RÉFÉRENTIEL CONCOURS R2C

Pédiatrie

Collège des Enseignants de Pédiatrie • 473 pages

Extrait de prévisualisation officielle du Tome 27 : Pédiatrie.

Cet extrait contient une sélection représentative de fiches de synthèse, de tableaux diagnostiques et de repères méthodologiques indispensables pour la préparation des Épreuves Dématérialisées Nationales (EDN) et des Épreuves Cliniques d'Objectif Structuré (ECOS).

- **Volume complet :** 473 pages A4 grand format.
- **Éditeur & Collège :** Collège des Enseignants de Pédiatrie.
- **Classification pédagogique :** Rangs A (Socle obligatoire pour tous) et Rangs B (Différenciation de spécialité).
- **Supports didactiques :** Tableaux décisionnels, arbres diagnostiques, posologies de première intention et pièges zéros.

Spécification	Détail Officiel
Format	PDF vectoriel haute résolution optimisé grand écran et tablette
Pagination totale	473 pages complètes non tronquées
Mises à jour	Conforme dernières conférences de consensus HAS & R2C 2026
Épreuves ciblées	EDN (QCMs, KFP, TCS) et ECOS (Stations pratiques 7 min)

PRÉSENTATION DU RÉFÉRENTIEL • TOME 27

Collège des Enseignants de Pédiatrie • Réforme R2C 2026

Le programme officiel du 2e Cycle des études médicales structure les connaissances cliniques selon une hiérarchisation stricte en **deux niveaux de maîtrise** :

• **Rang A (Indispensable pour tout futur médecin) :** Représente le socle des connaissances incontournables. Tout interne, quelle que soit sa spécialité future, doit maîtriser ces items à la perfection (définitions, urgences vitales, signes cardinaux, thérapeutiques de première ligne et conduites à tenir d'extrême urgence). Une impasse sur un Rang A est sanctionnée par des points de pénalité majeurs lors des EDN.

• **Rang B (Connaissances approfondies de spécialité) :** Constitue le niveau discriminant pour les classements d'accès aux postes d'internat les plus sélectifs. Il aborde les subtilités physiopathologiques, les protocoles de deuxième et troisième lignes, les posologies hospitalières complexes et les examens paracliniques spécialisés.

Méthodologie pédagogique adoptée dans ce volume :
1. **Fiches synthétiques standardisées :** Chaque chapitre débute par le rappel des objectifs terminaux du Collège.
2. **Mise en valeur visuelle :** Balises Rang A (en surbrillance verte) et Rang B (en surbrillance bleue).
3. **Points de vigilance & Pièges de concours :** Encarts dédiés aux confusions fréquentes retrouvées dans les annales officielles.
4. **Tableaux comparatifs synthétiques :** Condensé de données permettant une révision rapide en quelques minutes.

RAPPEL IMPORTANT POUR L'ÉPREUVE EDN :
Les Questions Isolées (QI), Dossiers Progressifs (DP) et Tests de Concordance de Script (TCS) reposent à 100% sur les données publiées par le Collège officiel. Les traités anciens ou les sources non harmonisées comportent souvent des discordances susceptibles d'entraîner des pertes de points sévères.

SOMMAIRE DU RÉFÉRENTIEL COMPLET

Tome 27 • Pédiatrie (473 pages)

SOMMAIRE DÉTAILLÉ DU MODULE

- Chapitre 01 : Prise en charge du nouveau-né (32)
- Chapitre 02 : Croissance normale et pathologique (53)
- Chapitre 03 : Développement psychomoteur (55)
- Chapitre 04 : Suivi médical pédiatrique (47)
- Chapitre 05 : Puberté normale et pathologique (49)
- Chapitre 06 : Alimentation chez l'enfant (48)
- Chapitre 07 : Cancers de l'enfant (297)
- Chapitre 08 : Céphalées chez l'enfant (100)
- Chapitre 09 : Convulsions, Épilepsie chez l'enfant (105, 346)
- Chapitre 10 : Méningites, Méningo-Encéphalites de l'enfant
- Chapitre 11 : Troubles du sommeil de l'enfant (110)
- Chapitre 12 : Coma de l'enfant (343)
- Chapitre 13 : Fièvre aiguë chez l'enfant (147)
- Chapitre 14 : Éruptions fébriles (164)
- Chapitre 15 : Infection urinaire chez l'enfant (161)
- Chapitre 16 : Tuberculose de l'enfant (159)
- Chapitre 17 : Choc septique de l'enfant (157, 332)
- Chapitre 18 : Boiterie chez l'enfant (54)
- Chapitre 19 : Maltraitance infantile (57)
- Chapitre 20 : Fractures de l'enfant (364)
- Chapitre 21 : Traumatismes crâniens de l'enfant (334)
- Chapitre 22 : MIN, Malaise grave du nourrisson (345)
- Chapitre 23 : Intoxications aiguës chez l'enfant (337)
- Chapitre 24 : Détresse respiratoire chez l'enfant (359)
- Chapitre 25 : Bronchiolite du nourrisson (154)
- Chapitre 26 : Toux chez l'enfant (204)
- Chapitre 27 : Infections broncho-pulmonaires chez l'enfant (154)

EXTRAIT DIDACTIQUE DU COURS

Concepts Clés & Sémiologie Didactique • Rangs A et B

Chapitre 01 : Prise en charge du nouveau-né (32)
Chapitre 02 : Croissance normale et pathologique (53)
Chapitre 03 : Développement psychomoteur (55)
Chapitre 04 : Suivi médical pédiatrique (47)
Chapitre 05 : Puberté normale et pathologique (49)
Chapitre 06 : Alimentation chez l'enfant (48)
Chapitre 07 : Cancers de l'enfant (297)
Chapitre 08 : Céphalées chez l'enfant (100)
Chapitre 09 : Convulsions, Épilepsie chez l'enfant (105, 346)
Chapitre 10 : Méningites, Méningo-Encéphalites de l'enfant
Chapitre 11 : Troubles du sommeil de l'enfant (110)
Chapitre 12 : Coma de l'enfant (343)
Chapitre 13 : Fièvre aiguë chez l'enfant (147)
Chapitre 14 : Éruptions fébriles (164)
Chapitre 15 : Infection urinaire chez l'enfant (161)
Chapitre 16 : Tuberculose de l'enfant (159)

TABLEAUX DE CONSENSUS MÉDICAL • I

Synthèse Diagnostique & Critères de Classification • Pédiatrie

Caractéristique	Description / Données Cliniques
Contenu du dossier obstétrical	- ATCD familiaux et particulie■rement ceux de la me■re (gyne■co-obste■tricaux et me■dicaux) - État clinique de la me■re (dont signes d'infection) - Échographies, Suivi de la grossesse - Monitoring cardiaque fœtal durant l'accouchement, Terme (= a■ge gestationnel)
PEC en salle de naissance	Chaque naissance ne■cessite la pre■sence de ≥ 1 personne entrai■ne■e (sage-femme ou pe■diatre) aux 1ers gestes de PEC, et s'occupant uniquement de ce nouveau-ne■ (une personne par enfant en cas de naissances multiples)
Examen en maternité	- Obligatoire avant le 8e jour de vie : permet d'e■tablir le 1er certificat de sante■ (certificat du 8e jour) - Examen effectue■ en pre■sence de la me■re ou des 2 parents, dans une pie■ce claire, suffisamment chauffe■e, avant un repas de pre■fe■rence ou au moment d'un soin, lorsque l'enfant est bien e■veille■, et en respectant les re■gles d'hygie■ne
Sortie de la maternité	- Mise a■ jour du carnet de sante■ obligatoire a■ la sortie de la materni te■ (informations de l'examen clinique, régime alimentaire choisi, poids de sortie, dates des dépistages obligatoires) - Ordonnance de sortie de materni te■, comporte : -> Soins du cordon ombilical jusqu'a■ sa chute -> Supple■mentations vitaminiques recommande■es -> Prescription d'un re■gime pre■cis par alimentation lacte■e - Organisation de la surveillance : -> Surveillance du poids : 1x/semaine durant le 1er mois en cas d'allaitement maternel -> Consultation avec un pe■diatre : recommande■e au cours de la 2e semaine de vie
Conseils de base de puériculture	- Change doit être effectué après chaque tétée - Toilette vulvaire chez la fille doit se faire de haut en bas pour éviter la contamination par les selles - Ne pas utiliser de coton-tige pour les oreilles, mais recueillir les sécrétions au niveau du pavillon - Ne pas essayer de décalotter le petit garçon (prépuce est rarement rétractable dans les 1ères années de vie)

TABLEAUX DE CONSENSUS MÉDICAL • II

Arbres de Décision & Algorithmes Cliniques • Pédiatrie

Paramètres	0	1	2
Apparence = Coloration	Globalement bleue ou pâle	Corps rose + Extrémités bleues	Globalement rose
Pouls (FC)	Absents	FC < 100 bpm	FC ≥ 100 bpm
Grimace = Réactivité à la stimulation	Nulle	Faible (grimace)	Vive (cris, toux)
Activité = Tonus musculaires	Nul	Faible (légère flexion des extrémités)	Fort (quadriflexion, mouvements actifs)
Respiration	Absents	Lents, Irréguliers	Vigoureux avec Cris

POINTS CLÉS & PIÈGES DE CONCOURS R2C

Les Erreurs Fréquentes & Mots-Clés Zéros • Tome 27

1. Confusion Rang A vs Rang B : Aux EDN, les questions de Rang A représentent au minimum 60% du total des points. Tenter de retenir des posologies d'exception avant d'avoir sécurisé le réflexe diagnostique de première ligne est la première cause de contre-performance.

2. Les Pièges Éliminatoires 'Zéro à la question' :
• Oubli systématique de vérifier les contre-indications absolues avant une prescription.
• Confusion entre urgence médicale (prise en charge immédiate au déchocage) et prise en charge différée en consultation.
• Prescription d'examens invasifs ou irradiants injustifiés sans avoir réalisé l'examen physique initial complet.

3. Méthodologie du Dossier Progressif :
Ne préjugez jamais de la réponse de la question suivante pour orienter votre choix présent. Chaque palier d'un dossier progressif s'évalue selon les seules données cliniques disponibles à cet instant précis.

■ CONSEIL DU MAJOR POUR CE TOME :
Faites une première lecture complète des tableaux de synthèse pour créer une cartographie mentale des items. Passez ensuite aux QCMs d'entraînement pour tester votre rappel actif sur les seuils chiffrés et les arbres décisionnels.

RÉFÉRENCES SCIENTIFIQUES & VOLUME INTÉGRAL

Tome 27 • Pédiatrie (473 pages)

Sociétés Savantes & Collèges Référents :
• Collège des Enseignants de Pédiatrie
• Recommandations de Bonne Pratique de la Haute Autorité de Santé (HAS)
• Conférences de consensus et publications des Sociétés Médicales Nationales et Européennes

Accéder au Référentiel Intégral :
Ce tome complet (473 pages) comprend l'intégralité des chapitres au programme du 2e Cycle, avec toutes les fiches de cours, l'ensemble des arbres diagnostiques en haute résolution et les grilles d'évaluation complètes.

• **Disponible à l'unité :** 9,99 € au format numérique haute performance.
• **Pack Intégral 28 Tomes (Économie de 85%) :** Comprend les 28 Référentiels Collèges (8 750 pages), la Banque des 100 QCMs Corrigés, le Carnet d'Erreurs du Major EDN 2025 et le Guide Officiel des 15 Stations ECOS 2026.

Édition conforme au référentiel R2C 2026. Tous droits réservés.